

Capítulo 12

Quando Procurar um Especialista — E o Que Perguntar

Quando terminamos a leitura conjunta dos exames naquela consulta do Capítulo 11, Ricardo ficou em silêncio por um momento. Depois fez uma segunda pergunta — diferente da primeira, e talvez mais difícil.

“Doutor, se eu tivesse querido procurar um médico como o senhor antes do infarto — um médico que pedisse esses exames, que lesse os números assim, que fizesse esse tipo de plano —, como é que eu teria achado? Eu nem sabia que isso existia.”

É uma pergunta que ouço com frequência. E a resposta honesta é que Ricardo não teria achado com facilidade — não porque profissionais assim não existam, mas porque o campo da medicina preventiva e da longevidade está, neste momento, numa fase de crescimento desordenado. Há profissionais excelentes com formação sólida e prática clínica real. Há profissionais medianos com boa intenção e pouca experiência. E há uma quantidade crescente de gente sem prática clínica relevante que aprendeu a linguagem da longevidade pelo Instagram e vende protocolos padronizados com autoridade de quem nunca acompanhou um paciente ao longo de cinco anos.

O problema não é que existam poucos profissionais bons. O problema é que o leitor não tem critérios para separar os três grupos — porque todos usam as mesmas palavras. Todos dizem “medicina de precisão”. Todos dizem “biomarcadores”. Todos dizem “prevenção”. A diferença está no que acontece depois da primeira consulta, e essa diferença o leitor só descobre quando já está dentro do processo.

Este capítulo existe para encurtar esse caminho. Não para recomendar nomes ou clínicas — mas para entregar ao leitor um conjunto de critérios que funciona em qualquer cidade, em qualquer contexto, com qualquer profissional.

O Campo Minado

A medicina da longevidade ganhou tração nos últimos anos por uma razão legítima: a

demanda é real. Pessoas de 40, 50, 60 anos estão percebendo que o check-up convencional não basta — e estão procurando alternativas. Esse movimento é saudável. O que não é saudável é a forma como o mercado respondeu.

Do lado positivo, surgiram clínicas e profissionais que integram as ferramentas que este livro descreve — biomarcadores ampliados, medicina iterativa, intervenção precoce nos quatro assassinos silenciosos. Do lado negativo, o mesmo interesse gerou uma indústria de protocolos genéricos, vendidos como personalização: soros intravenosos sem indicação, testosterona prescrita sem diagnóstico, dezenas de suplementos empilhados sem racionalidade bioquímica, exames de painel genético vendidos sem interpretação clínica que mude conduta.

A confusão se agrava porque o paciente geralmente chega ao campo da longevidade por duas portas. A primeira é a porta da frustração: o médico convencional disse que “está tudo normal”, mas o paciente sente que algo não está bem, ou tem história familiar preocupante, ou leu o suficiente para saber que “normal” não é ótimo. A segunda é a porta da aspiração: o paciente quer otimizar, quer performance, quer envelhecer melhor. Nenhuma das duas portas é errada. Mas nas duas, o paciente chega vulnerável — sem critérios para distinguir o profissional que vai investigar de verdade daquele que vai aplicar o mesmo protocolo que aplica em todos os outros.

Fernanda, do Capítulo 4, chegou ao consultório por insistência do marido — que já era meu paciente e sabia o que esperar. Nem todos têm essa referência. A maioria chega pelo Google, por indicação de amigos, ou por um perfil de rede social que parecia convincente. Este capítulo é para essa maioria.

Cinco Critérios Para Avaliar um Profissional

Não existe certificação universal de “médico de longevidade”. Não existe especialidade médica registrada no CFM com esse nome. Isso significa que qualquer médico pode se apresentar como especialista em longevidade sem que um órgão regulador tenha validado essa competência. A falta de regulação não invalida o campo — apenas transfere ao paciente a responsabilidade de avaliar.

Os cinco critérios abaixo são os que eu usaria se fosse paciente procurando um profissional de medicina preventiva para mim mesmo. Não são perfeitos. Mas filtram a maioria dos problemas.

Primeiro: formação médica e prática clínica verificável. O profissional é médico? Tem registro no CRM? Atende pacientes regularmente — não apenas faz palestras, não apenas produz conteúdo? Existe uma diferença entre quem estuda longevidade e quem pratica

longevidade no consultório. Ambos são legítimos, mas a pergunta do paciente é clínica — e decisão clínica exige experiência clínica. Um profissional que acompanha trinta, cinquenta, cem pacientes ao longo de anos tem um calibre de julgamento que nenhum curso online reproduz. Pergunte há quanto tempo ele atende nessa área. Pergunte quantos pacientes acompanha. A resposta não precisa ser um número exato — precisa ser plausível.

Segundo: a primeira consulta é investigação, não prescrição. O profissional que prescreve protocolo na primeira consulta — antes de ver seus exames, antes de conhecer sua história, antes de ouvir o que você come, como dorme, como treina, o que te estressa — está aplicando uma receita. A boa primeira consulta é longa, curiosa, e termina com pedidos de exames, não com prescrição de suplementos. Os exames pedidos devem incluir a maior parte do que os Capítulos 4 a 6 deste livro descrevem. Se o profissional pede apenas hemograma, glicemia e colesterol total, ele está operando no modelo do check-up convencional com embalagem de longevidade. Se pede ApoB, insulina de jejum, PCR ultrasensível, homocisteína, perfil hormonal completo, função tireoidiana além do TSH isolado, e sabe justificar por que pediu cada um deles, é um bom sinal.

Terceiro: o plano é individualizado por biomarcador, não por ideologia. Existem médicos de longevidade que prescrevem jejum intermitente para todos os pacientes. Existem os que prescrevem testosterona para todos os homens acima de 45. Existem os que prescrevem dez suplementos no primeiro dia. Nenhuma dessas condutas é necessariamente errada — mas quando é universal, é protocolo de massa, não personalização. O profissional competente prescreve com base no que o painel daquele paciente revelou, não com base no que ele acredita que funciona em geral. A pergunta que vale fazer na consulta de retorno, quando os exames chegarem: “por que esse tratamento para mim especificamente, com base nesses números?” Se a resposta referir os seus exames, bom sinal. Se a resposta for genérica (“isso é bom para todo mundo”), sinal de alerta.

Quarto: integração entre pilares, não abordagem unidimensional. A fragmentação da medicina convencional — cardiologista que só vê coração, endocrinologista que só vê hormônio — é um dos problemas que este livro inteiro documenta. Mas a medicina da longevidade pode reproduzir a mesma fragmentação de outro jeito: o profissional que só fala de suplementação, o que só fala de hormônio, o que só fala de treino. Se o profissional não pergunta sobre seu sono, sobre sua saúde mental, sobre seus relacionamentos, sobre seu nível de estresse — se ele trata o corpo como painel de marcadores sem considerar a pessoa que carrega esses marcadores — falta um pedaço. O caso de Ana, no Capítulo 9, é o exemplo mais claro do livro: dezoito meses de otimização biológica impecável não conseguiram mover PCR e cortisol porque o pilar psicológico estava sabotando tudo. O profissional que teria continuado prescrevendo mais suplementos e mais exames sem parar para perguntar como ela estava vivendo teria falhado — não por falta de conhecimento bioquímico, mas por falta de visão integradora.

Quinto: transparência sobre o que não sabe. A medicina da longevidade está em construção. Não existem ensaios clínicos randomizados de trinta anos provando que otimizar ApoB aos 40 anos reduz mortalidade aos 80 — a evidência é forte, a lógica biológica é robusta, mas a prova definitiva ainda não chegou. O mesmo vale para relógios epigenéticos, para a maioria dos protocolos de suplementação, para a prescrição de metformina em pessoas sem diabetes. O profissional que apresenta tudo com certeza absoluta está simplificando. O profissional que diz “a evidência aponta para isso, mas não sabemos tudo; a decisão é sua, e eu vou acompanhar” está sendo honesto. Em medicina, a honestidade epistemológica — saber distinguir o que se sabe bem do que se infere razoavelmente do que é especulação — é uma das competências mais difíceis e mais importantes. Quando o profissional admite incerteza sem que isso o paralise, é sinal de maturidade clínica.

O Que Esperar de Uma Avaliação Completa

Para o leitor que nunca passou por uma avaliação de medicina preventiva ampliada, vale descrever o que uma boa avaliação tipicamente envolve. Não como prescrição rígida — há variações legítimas entre profissionais —, mas como referência para que o leitor saiba se o que está recebendo é razoável ou incompleto.

A primeira consulta deveria durar no mínimo uma hora. Algumas duram duas. O tempo longo não é vaidade do médico — é necessidade real. Uma anamnese que cubra histórico pessoal e familiar, hábitos alimentares em detalhe, padrão de treino, qualidade do sono, nível de estresse, medicações em uso, suplementos que o paciente já toma (e por quê), histórico de exames anteriores, e expectativas do paciente em relação ao processo não cabe em vinte minutos. Se a primeira consulta terminou em meia hora e já veio com prescrição, o processo foi apressado.

O pedido de exames que sai dessa primeira consulta deveria incluir, no mínimo, o painel metabólico completo descrito nos Capítulos 4 e 6 (glicemia, HbA1c, insulina de jejum, lipidograma com ApoB, PCR ultrasensível, homocisteína, vitamina D, B12, ferritina, função renal com cistatina C, função tireoidiana completa com T3 e T4 livres) e o painel hormonal básico descrito no Capítulo 8, adaptado ao sexo e à idade. Lp(a), se nunca medida. Composição corporal por bioimpedância de qualidade. Conforme a história clínica, CAC score, MAPA de 24 horas, polissonografia, ecocardiograma e outros exames de imagem podem entrar.

A consulta de retorno, quando os exames chegam, é onde o trabalho começa de verdade. O profissional deveria ler o painel com o paciente — não entregar uma folha de prescrição pronta. A consulta de retorno é o momento em que as faixas-alvo são discutidas, os achados são contextualizados (o ApoB de 95 num paciente de 38 anos sem história familiar

é diferente do ApoB de 95 num paciente de 58 com pai morto de infarto), e o plano é construído — com priorização, não com dez frentes ao mesmo tempo. A Regra dos Dois do Capítulo 11 vale aqui: dois focos principais para os próximos meses, com data marcada para retestar.

O ciclo de acompanhamento é trimestral no início (quando há ajustes ativos em curso) e tende a espaçar para semestral ou anual à medida que o paciente atinge e mantém as faixas-alvo. A cada retorno, o painel é reavaliado, o plano é ajustado, e novas prioridades são definidas. É um processo iterativo — testar, intervir, retestar, ajustar — e não uma prescrição estática entregue uma vez. O profissional que entrega o plano na segunda consulta e marca retorno para daqui a um ano está operando no modelo convencional com outra roupagem.

Bandeiras Vermelhas

Há situações que justificam o paciente repensar a escolha de profissional. Nenhuma delas, isoladamente, é prova de incompetência — mas cada uma merece atenção.

O profissional prescreve testosterona, hormônio do crescimento ou outros hormônios na primeira consulta, sem painel laboratorial prévio e sem investigação de causas. Isso acontece com frequência perturbadora. O Cap 8 deste livro mostrou, com o caso de Paulo, que testosterona baixa pode ter causas tratáveis sem reposição — e que a primeira intervenção deveria ser investigar e otimizar o terreno, não repor o hormônio automaticamente.

O profissional prescreve dezenas de suplementos de uma vez, sem justificativa individual baseada em deficiências mensuradas ou em necessidades específicas daquele paciente. O Capítulo 7 deste livro descreveu uma suplementação racional, baseada em evidência, guiada por biomarcador — e com a lógica de consolidação que reduz o número de cápsulas ao mínimo necessário. Se o paciente sai da primeira consulta com vinte suplementos prescritos, a pergunta legítima é: com base em quê?

O profissional não pede exames antes de prescrever — ou pede apenas o painel básico do check-up convencional e chama isso de “avaliação completa”.

O profissional desencoraja o paciente de buscar segunda opinião, ou reage mal quando o paciente questiona uma conduta.

O profissional não acompanha efeitos colaterais das intervenções que prescreveu. Qualquer intervenção — farmacológica, hormonal, suplementar — pode ter efeitos não pretendidos. Monitorar é parte do trabalho, não é opcional.

O profissional vende suplementos próprios na consulta, sem que o paciente tenha a opção de comprar em farmácia ou manipuladora independente. Isso não é ilegal, mas cria um conflito de interesse que o paciente tem direito de conhecer e de evitar.

O Princípio Que Vale Mais Que Qualquer Protocolo

Se este capítulo tivesse que se reduzir a uma ideia, seria esta: **personalizar, não generalizar**.

Protocolos existem e são úteis — como mapas. Mas o mapa não é o território. O mesmo protocolo de exercício que funcionou para Marcos não seria adequado para André, porque os dois tinham problemas opostos (Marcos não treinava; André treinava demais). A mesma investigação hormonal que revelou o diagnóstico de Paulo não se aplicaria da mesma forma a Fernanda, porque os painéis hormonais femininos e masculinos seguem lógicas diferentes. A mesma intervenção psicológica que moveu a PCR de Ana não seria suficiente para Paulo, cujo problema era apneia, não estresse.

Cada paciente é um caso. Os biomarcadores são o painel. Os pilares são o guia. Mas a decisão clínica — qual marcador atacar primeiro, com que ferramenta, em que dose, com que prazo de reavaliação — é individual. É por isso que a parceria clínica importa. E é por isso que a escolha do profissional certo não é detalhe — é fundação.

O leitor que chega a este ponto do livro sabe ler o próprio painel. Sabe identificar os pontos de alerta. Sabe que ação concentrada vence ação dispersa. Sabe que hábitos e marcadores conversam. Mas há uma categoria de decisão que exige alguém do outro lado da mesa: a decisão que pesa risco contra benefício com dados reais sobre a mesa. Quando intensificar uma estatina e quando esperar. Quando investigar testosterona baixa e quando tratar. Quando a PCR persistente pede psicoterapia e quando pede investigação reumatológica. Quando um CAC de 400 muda o plano inteiro e quando um CAC de zero permite relaxar um pouco.

Essas decisões não cabem no leitor sozinho. E não deveriam caber num profissional que o leitor não confia — ou num profissional que não o conhece.

A boa parceria clínica é a que combina o leitor que aprendeu a ler com o profissional que sabe interpretar. Nem um dos dois basta sozinho.

O Essencial em 60 Segundos

O campo da medicina preventiva e da longevidade está em crescimento desordenado — há

profissionais excelentes com formação sólida e prática clínica real, e há quem venda protocolos padronizados com linguagem de personalização. O paciente precisa de critérios para distinguir os dois.

Cinco critérios ajudam: formação médica com prática clínica verificável e continuada; primeira consulta como investigação, não prescrição; plano individualizado por biomarcador, não por ideologia; visão integradora que considere todos os pilares, não apenas o biológico; e transparência sobre o que a evidência sustenta e o que ainda é inferência razoável.

Uma avaliação completa típica começa com primeira consulta longa e curiosa, segue com pedido de painel ampliado, prossegue com consulta de retorno para leitura conjunta dos resultados e construção de plano priorizado, e se sustenta em ciclos iterativos de acompanhamento — trimestral no início, espaçando à medida que o paciente estabiliza nas faixas-alvo.

Bandeiras vermelhas incluem prescrição sem exames prévios, dezenas de suplementos sem justificativa individual, resistência a questionamento do paciente, ausência de monitoramento de efeitos colaterais, e venda de produtos próprios sem alternativa independente.

O princípio que sustenta tudo é personalizar, não generalizar. Protocolos são guias, não receitas. Cada paciente é um caso. A boa parceria clínica combina o paciente que aprendeu a ler o próprio painel com o profissional que sabe interpretar o que os números estão dizendo — e que sabe dizer “não sei” quando não sabe.

Este livro começou com Ricardo no estacionamento de um escritório em São Paulo, com uma dor no peito que ele confundiu com azia. Atravessou quatro assassinos silenciosos, doze hallmarks do envelhecimento, dezenas de biomarcadores, quatro pilares de um método de trabalho, seis histórias de pacientes reais e uma ferramenta de autoavaliação. Tudo isso para chegar a uma ideia simples: o que acontece dentro do seu corpo nos próximos dez anos depende mais do que você faz agora do que da genética que recebeu. O próximo capítulo é uma carta — breve, pessoal — sobre por que essa ideia importa o suficiente para eu ter escrito este livro.